

PROSTATITIS AGUDA

Ruben Benitez Paredes, Z. Danz Luque.

INTRODUCCIÓN

La prostatitis es la inflamación de la próstata, puede ser prostatitis aguda bacteriana ó prostatitis crónica (bacteriana o no bacteriana). Causa más frecuente E. Coli.

Presentación clínica

Mal estado general, fiebre alta, escalofríos, mialgias, polaquiuria, tenesmo vesical, retención aguda de orina, dolor perineal ocasionalmente irradiado a glánde. Dolor lumbosacro, en cara interna de muslo, región inguinal o testicular. Antecedente de sondaje vesical, o ITUs.

DIAGNÓSTICO

Exploración física

- Interrogatorio: Antecedentes de ITU, sondajes.
- Temperatura >38°C
- Tacto rectal: Próstata aumentado de volumen, caliente, tenso, más sensible al tacto. EVITAR MASAJE POR RIESGO DE BACTERIEMIA.

Exámenes complementarios

- **Hemograma** con fórmula y recuento leucocitarios.
- **Bioquímica** sanguínea con función renal: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, PCR. Si sospecha de sepsis procalcitonina y lactato.
- **coagulación** básica. Si se sospecha de sepsis o tratamiento anticoagulante.
- **Sistemático** y sedimento de orina.
- **Urocultivo**. Antes de iniciar tratamiento antibiótico.
- **Radiografía** de abdomen simple. Se solicitara si presenta dolor abdominal y si la prostatitis es de evolución crónica para descartar litiasis en seno glandular.

Criterios de ingreso

- Fiebre alta con alteración del estado general con sospecha de sepsis.
- Ingreso en observación las primeras 24h para las primeras dosis de tratamiento parenteral y evolución clínica.
- Retención aguda de Orina.

Complicaciones

- Absceso prostático, prostatitis crónica, orquitis, sepsis.

TRATAMIENTO

En Observación:

- Reposo en cama, uso de laxantes, baño de asientos, ingesta hídrica de aprox 1,5 - 2 litros /día
- Antitérmico-Analgésico:
 - Paracetamol 1gr c/8h IV . /Dexketoprofeno 1 amp c/8h IV.
- Antibioticoterapia:
 - Amoxicilina/Acido clavulanico 1gr c/8hs durante 4 semanas.

- Cefonicid 1gm c/24horas
- Cefalosporina de tercera generación (cefotaxima 1-2 g c/8 horas, ceftriaxona 1-2 g c/24horas) o en caso de Pseudomonas aeruginosa ceftazidima 1-2 g/8 horas.
- Fluorquinolonas (Ciprofloxacino 500mg c/12horas vía oral ó 400mg c/12horas intravenosa durante 1 mes. o Levofloxacino 500mg cada 24horas durante 1 mes VO/IV).
- Gentamicina/tobramicina (5mg/kg/24horas). Puede asociarse a quinolonas o cefalosporinas.
- Tobramicina 100mg c/12horas
- Interconsulta Urología.

En Domicilio:

1. Medidas generales: reposo, baños de asientos, laxantes, abundante ingesta de líquidos, analgésico/antitérmicos (AINES).

2. Antibioticoterapia vía oral, según antibiograma: 4 – 6 semanas:

- Amoxicilina/clavulanico 875/125mg c/8horas.
- Doxiciclina 100 cada 12hs.
- Cefuroxima 500 cada 12hs.
- Ciprofloxacino 500 cada 12hs
- Levofloxacino 500 cada 12hs
- Cotrimoxazol 800/160 cada 12hs.

3. Se puede asociar **alfabloqueantes** si hay síndrome miccional:

- Tansulosina 0,4mg c/24horas.
- Alfuzosina 10mg c/24horas.
- Silodosina 8mg c/24horas.
- Doxazosina 4mg c/24horas.

RECORDAR

- Ante sospecha de Prostatitis, pensar en posibilidad de sepsis.

Malestar general, fiebre alta,
síntomas miccionales,
dolor perineal.
PROSTATITIS

E. Física
T°: >38°C
Tacto Rectal:
Próstata sensible
Y aumentado.

Tratamiento:
Medidas generales.
En observación:
• Paracetamol 1gm IV
• Amoxi/Clav 1gm c/8hs.
En domicilio. 4-6sem.V.O.
• Paracetamol 1gm c/8hs
• Dextetoprofeno 25 c/8hs
• Amoxi/clav 500mg c/8hs.

Análítica:
Hemograma
Función renal
Pensar sepsis

BIBLIOGRAFÍA

- M.J. Clemente Millán, E. Martínez Acevedo, L. Llamas Quiñones,
- L. Jiménez Murillo y F.J. Montero Pérez. Prostatitis Aguda. En: Luis Jiménez Murillo; F. Javier Montero Pérez. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5ª Edición. España: Elsevier; 2015. 545-546.
- B. Lopez Prada, R. Iban Ochoa, M.J. Corullón Fernández. Infecciones del Tracto Urinario. En: Manuel José Vázquez Lima, José Ramón Casal Codesido. Guía de actuación en Urgencias. 4ª Edición. 2012. 246-247